Casos clínicos

Tema: Medicina Interna – Síndrome coronario agudo con elevación del ST

Hombre de 58 años, diabético e hipertenso, inicia hace 90 minutos con dolor opresivo retroesternal irradiado a brazo izquierdo, acompañado de diaforesis y náusea. TA 140/90 mmHg, FC 96 lpm. ECG muestra elevación del ST en II, III y aVF. Hospital sin sala de hemodinamia; el centro con angioplastia más cercano está a 3 horas.

Pregunta 1. ¿Cuál es el diagnóstico?
A) Angina inestable
B) IAM sin elevación del ST
C) IAM con elevación del ST inferior*
D) Pericarditis aguda
E) Disección aórtica

Pregunta 2. ¿Cuál es la estrategia de reperfusión indicada?
A) Traslado inmediato sin tratamiento
B) Fibrinólisis inmediata*
C) Solo antiagregación
D) Observación 6 horas
E) Anticoagulación oral

Pregunta 3. ¿Qué arteria está más probablemente involucrada?
A) Descendente anterior
B) Circunfleja
C) Coronaria derecha*
D) Tronco coronario izquierdo
E) Septal

Retroalimentación:
Elevación del ST en cara inferior (II, III, aVF) indica IAM inferior, usualmente por oclusión de coronaria derecha. Si la angioplastia no puede realizarse en menos de 120 minutos, la GPC de SCA con elevación del ST indica fibrinólisis inmediata. La angina inestable y el NSTEMI no presentan elevación persistente del ST. La pericarditis muestra elevación difusa, no regional.

Grado de dificultad: Medio

🩺 **CASO CLÍNICO 23**

Tema: Pediatría – Crisis asmática

Niño de 7 años con antecedente de asma, presenta disnea progresiva tras infección viral. Habla en frases cortas, FR 38/min, tiraje intercostal, sibilancias audibles sin estetoscopio, $SatO_2$ 89%.

Pregunta 1. ¿Cómo se clasifica la crisis?
A) Leve
B) Moderada
C) Grave*
D) Paro respiratorio inminente
E) Intermitente

Pregunta 2. Manejo inicial indicado:
A) Corticoide inhalado únicamente
B) Salbutamol nebulizado + oxígeno*
C) Antibiótico IV
D) Teofilina oral
E) Observación

Pregunta 3. ¿Qué dato indica mayor gravedad?
A) Tos nocturna
B) Sibilancias
C) Saturación <90%*
D) Historia familiar
E) Fiebre

Retroalimentación:
$SatO_2$ <90%, uso de músculos accesorios y dificultad para hablar indican crisis grave según GPC de asma en pediatría. El tratamiento inicial es oxígeno y beta2 agonista de acción corta repetido. Los esteroides sistémicos deben añadirse tempranamente, pero nunca como monoterapia inicial. La teofilina ya no es de primera línea.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 24

Tema: Cirugía – Pancreatitis aguda

Hombre de 45 años, etilista crónico, presenta dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, vómito persistente. Lipasa 6 veces el límite superior. TA 100/60 mmHg, FC 112 lpm. BUN 32 mg/dL.

Pregunta 1. ¿Cuál es el diagnóstico?
A) Colecistitis
B) Úlcera perforada
C) Pancreatitis aguda*
D) Isquemia mesentérica
E) Hepatitis alcohólica

Pregunta 2. ¿Qué dato indica peor pronóstico inicial?
A) Dolor irradiado
B) Lipasa elevada
C) BUN elevado*
D) Edad <50
E) Náusea

Pregunta 3. Manejo inicial:
A) Antibiótico profiláctico
B) Reposición vigorosa con cristaloides*
C) CPRE urgente
D) Cirugía inmediata
E) Dieta líquida

Retroalimentación:
El diagnóstico requiere dolor típico más elevación de lipasa ≥3 veces el límite superior. El aumento de BUN y la hipotensión indican mayor severidad según criterios pronósticos. El tratamiento inicial es hidratación agresiva con solución isotónica. Los antibióticos no están indicados de rutina y la CPRE solo si hay colangitis o coledocolitiasis.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 25

Tema: Ginecología – Cáncer de endometrio

Mujer de 62 años, menopausia a los 50, obesa y diabética, consulta por sangrado transvaginal escaso indoloro. USG transvaginal muestra grosor endometrial de 16 mm.

Pregunta 1. Principal factor de riesgo en esta paciente:
A) Multiparidad
B) Uso de anticonceptivos
C) Hiperestrogenismo sin oposición*
D) Tabaquismo
E) Infección por VPH

Pregunta 2. Siguiente paso diagnóstico:
A) CA-125
B) Papanicolaou
C) Biopsia endometrial*
D) Histerectomía directa
E) Observación

Retroalimentación:
Sangrado postmenopáusico con endometrio >4 mm obliga a biopsia endometrial según GPC de cáncer de endometrio. La obesidad y diabetes favorecen hiperestrogenismo periférico sin oposición, principal factor de riesgo. El Papanicolaou no diagnostica cáncer endometrial y los marcadores tumorales no son estudio inicial.

Grado de dificultad: Medio

Tema: Medicina Interna – Enfermedad renal crónica y manejo de anemia

Hombre de 64 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión de 20 años de evolución acude a consulta por fatiga progresiva y disminución de la tolerancia al ejercicio. TA 150/95 mmHg. Presenta palidez de tegumentos y edema leve en extremidades inferiores. Laboratorio: Hb 8.9 g/dL, VCM 88 fL, creatinina 3.2 mg/dL, TFG estimada 22 ml/min/1.73 m^2, ferritina normal, saturación de transferrina normal.

Pregunta. ¿Cuál es el manejo más adecuado de la anemia en este paciente?
A) Transfusión inmediata
B) Hierro intravenoso
C) Eritropoyetina recombinante*
D) Ácido fólico
E) Observación

Retroalimentación:
Paciente con ERC estadio 4 (TFG <30) y anemia normocítica normocrómica con depósitos de hierro adecuados sugiere déficit de eritropoyetina. La GPC de

Enfermedad Renal Crónica indica uso de agentes estimulantes de eritropoyesis cuando Hb <10 g/dL tras descartar deficiencia de hierro. No requiere transfusión salvo inestabilidad o Hb muy baja.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 27

Tema: Pediatría – Intususcepción intestinal

Lactante de 8 meses previamente sano presenta episodios súbitos de llanto intenso con flexión de piernas sobre el abdomen, vómito y posteriormente evacuación con moco y sangre. A la exploración se palpa masa en cuadrante superior derecho. USG reporta imagen en "diana".

Pregunta 1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A) Apendicitis
B) Gastroenteritis
C) Invaginación intestinal*
D) Hernia incarcerada
E) Malrotación

Pregunta 2. Conducta inicial más adecuada:
A) Laparotomía inmediata
B) Enema neumático terapéutico*
C) Antibióticos IV
D) Observación
E) Colonoscopia

Retroalimentación:
La triada clásica (dolor cólico intermitente, masa palpable y evacuaciones en jalea de grosella) orienta a invaginación. Según GPC de abdomen agudo en pediatría, el tratamiento inicial en paciente estable es reducción con enema neumático o hidrostático. La cirugía se reserva para fracaso o perforación.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 28

Tema: Ginecología – Amenorrea secundaria

Mujer de 23 años con antecedente de pérdida de peso importante en los últimos 6 meses por dieta restrictiva y ejercicio excesivo. Refiere ausencia de menstruación desde hace 5 meses. β-hCG negativa. TSH y prolactina normales. FSH y LH bajas.

Pregunta. ¿Cuál es la causa más probable?
A) Síndrome de ovario poliquístico
B) Insuficiencia ovárica prematura
C) Amenorrea hipotalámica funcional*
D) Hiperprolactinemia
E) Síndrome de Asherman

Retroalimentación:
La pérdida de peso, ejercicio excesivo y gonadotropinas bajas indican supresión hipotalámica funcional. La GPC de amenorrea secundaria señala que FSH/LH bajas con factores de estrés metabólico sugieren origen central. En insuficiencia ovárica la FSH estaría elevada.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 29

Tema: Cirugía – Isquemia mesentérica aguda

Hombre de 72 años con fibrilación auricular sin anticoagulación presenta dolor abdominal súbito intenso “desproporcionado” a la exploración física. Abdomen blando, sin datos claros de irritación peritoneal. Lactato elevado.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Pancreatitis
B) Isquemia mesentérica aguda embólica*
C) Apendicitis
D) Diverticulitis
E) Oclusión intestinal

Pregunta 2. Estudio diagnóstico de elección:
A) Radiografía simple
B) Ultrasonido abdominal
C) AngioTAC abdominal*
D) Colonoscopia
E) Enema contrastado

Retroalimentación:
Dolor intenso desproporcionado con antecedente de FA sugiere embolia mesentérica. La GPC de abdomen agudo recomienda AngioTAC como estudio diagnóstico inicial en paciente estable. La radiografía simple tiene baja sensibilidad. El retraso diagnóstico aumenta mortalidad.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 30

Tema: Medicina Interna – Hipotiroidismo primario

Mujer de 45 años con aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento y piel seca. FC 54 lpm. Laboratorio: TSH 18 mUI/L, T4 libre baja.

Pregunta. Tratamiento inicial indicado:
A) Metimazol
B) Propiltiouracilo
C) Levotiroxina*
D) Yodo radioactivo
E) Propranolol

Retroalimentación:
TSH elevada con T4 baja confirma hipotiroidismo primario. La GPC de patología tiroidea establece levotiroxina como tratamiento de elección ajustando dosis según edad y comorbilidades. Los antitiroideos se usan en hipertiroidismo, no en hipofunción.

Grado de dificultad: Bajo

Tema: Oncología Ginecológica P2 – Tamizaje y manejo inicial de CaCu

Mujer de 41 años, G4P4, inicio de vida sexual a los 16 años, múltiples parejas sexuales. Refiere que su última citología fue hace 6 años. Acude para chequeo. Se realiza prueba de VPH que resulta positiva para genotipo 16. Citología reporta NILM (negativa para lesión intraepitelial). No síntomas.

Pregunta 1. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
A) Repetir citología en 3 años
B) Repetir VPH en 5 años
C) Colposcopía inmediata*

D) Conización diagnóstica
E) Histerectomía

Pregunta 2. Si la colposcopía muestra lesión acetoblanca compatible con NIC 2, el manejo indicado es:
A) Observación
B) Crioterapia
C) Escisión electroquirúrgica (LEEP)*
D) Antibiótico
E) Radioterapia

Retroalimentación:
Según NOM-014 y GPC de cáncer cervicouterino, VPH 16 positivo requiere colposcopía aunque la citología sea negativa. NIC 2 es lesión de alto grado y debe tratarse con método excisional como LEEP. La observación se reserva para NIC 1 en casos seleccionados.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 32

Tema: Pediatría – Infecciones TORCH (Toxoplasmosis congénita)

RN de 10 días con ictericia persistente, hepatoesplenomegalia y microcefalia. Presenta convulsiones. USG transfontanelar muestra calcificaciones intracraneales difusas. Madre refiere haber tenido contacto frecuente con gatos durante el embarazo.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Citomegalovirus
B) Rubéola congénita
C) Toxoplasmosis congénita*
D) Sífilis congénita
E) Herpes neonatal

Pregunta 2. Tratamiento indicado:
A) Penicilina G
B) Aciclovir
C) Pirimetamina + sulfadiazina + ácido folínico*
D) Ganciclovir
E) Observación

Retroalimentación:
La triada clásica de toxoplasmosis congénita incluye calcificaciones intracraneales difusas, hidro/microcefalia y coriorretinitis. El tratamiento recomendado por GPC de infecciones congénitas es pirimetamina más sulfadiazina y ácido folínico para prevenir mielosupresión. CMV suele dar calcificaciones periventriculares, no difusas.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 33

Tema: Nefrología – Síndrome nefrítico (Glomerulonefritis postestreptocócica)

Niño de 8 años con antecedente de faringitis hace 3 semanas, presenta edema palpebral, hematuria macroscópica y oliguria. TA 135/85 mmHg. Laboratorio: creatinina ligeramente elevada, C3 disminuido.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Síndrome nefrótico
B) Glomerulonefritis postestreptocócica*
C) Púrpura de Henoch-Schönlein
D) Nefropatía por IgA
E) LRA prerrenal

Pregunta 2. Manejo inicial:
A) Corticoides
B) Antibiótico prolongado
C) Restricción hídrica y control de TA*
D) Diálisis inmediata
E) Inmunosupresores

Retroalimentación:
Hematuria, hipertensión y complemento bajo tras infección estreptocócica sugieren glomerulonefritis postestreptocócica. El manejo es de soporte con control de líquidos y presión arterial según GPC de glomerulopatías. Los esteroides no son de primera línea.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 34

Tema: ATLS P1 – Manejo inicial del trauma

Hombre de 25 años sufre accidente automovilístico. Llega consciente pero agitado, con estridor audible y hematoma cervical expansivo. TA 100/60 mmHg, FC 120 lpm.

Pregunta. ¿Cuál es la prioridad inmediata?
A) Tomografía cervical
B) Intubación orotraqueal inmediata*
C) Radiografía de tórax
D) Colocación de sonda vesical
E) Analgesia IV

Retroalimentación:
En el enfoque ATLS, la vía aérea es la primera prioridad. Estridor y hematoma cervical expansivo indican riesgo inminente de obstrucción. Debe asegurarse la vía aérea antes de estudios de imagen. El retraso puede resultar en paro respiratorio.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 35

Tema: Reumatología – Vasculitis (Granulomatosis con poliangitis)

Hombre de 48 años con sinusitis crónica, epistaxis recurrente, hemoptisis y hematuria. Creatinina elevada. ANCA positivo tipo c-ANCA.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Lupus eritematoso sistémico
B) Poliarteritis nodosa
C) Granulomatosis con poliangitis*
D) Síndrome de Goodpasture
E) Artritis reumatoide

Pregunta 2. Tratamiento inicial indicado:
A) AINE
B) Metotrexato solo
C) Corticoide sistémico + ciclofosfamida*
D) Penicilina
E) Observación

Retroalimentación:
Afectación de vía aérea superior, pulmón y riñón con c-ANCA positivo es

característico de granulomatosis con poliangitis. El manejo de inducción incluye corticoide sistémico más inmunosupresor potente como ciclofosfamida o rituximab según GPC de vasculitis. Sin tratamiento puede evolucionar rápidamente a falla renal.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 36

Tema: Diabetes Mellitus – Tratamiento farmacológico (Medicina Interna)

Mujer de 52 años con DM2 desde hace 6 años en tratamiento con metformina a dosis máxima tolerada. IMC 34 kg/m^2. HbA1c 9.2%. TFG 85 ml/min. Refiere antecedente de infarto hace 2 años. No hipoglucemias previas.

Pregunta 1. ¿Cuál es el siguiente fármaco más indicado?
A) Sulfonilurea
B) Insulina NPH
C) Inhibidor SGLT2*
D) Acarbosa
E) Pioglitazona

Pregunta 2. ¿Cuál es el principal beneficio adicional de este grupo farmacológico en esta paciente?
A) Disminuye riesgo de hipoglucemia grave
B) Reduce eventos cardiovasculares mayores*
C) Aumenta secreción pancreática
D) Corrige resistencia periférica
E) Estimula liberación de GLP-1

Retroalimentación:
En paciente con DM2 y enfermedad cardiovascular establecida, la GPC de tratamiento de diabetes recomienda añadir un inhibidor SGLT2 o agonista GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado. Los SGLT2 reducen eventos cardiovasculares y progresión de ERC. Las sulfonilureas no aportan beneficio CV y aumentan riesgo de hipoglucemia.

Grado de dificultad: Alto

🩺 **CASO CLÍNICO 37**

Tema: Choque obstétrico y hemorragia obstétrica

Mujer de 24 años, G2P2, 30 minutos posterior a parto vaginal eutócico presenta sangrado abundante. TA 85/50 mmHg, FC 130 lpm. Útero aumentado de tamaño y flácido a la palpación. Placenta completa.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Retención placentaria
B) Atonía uterina*
C) Desgarro cervical
D) Inversión uterina
E) Coagulopatía primaria

Pregunta 2. Primera intervención terapéutica:
A) Legrado uterino
B) Masaje uterino + oxitocina IV*
C) Histerectomía inmediata
D) Ácido tranexámico como único manejo
E) Observación

Retroalimentación:
La causa más frecuente de hemorragia posparto es atonía uterina. El manejo inicial según GPC de hemorragia obstétrica incluye masaje uterino bimanual y administración de uterotónicos (oxitocina). Solo si no responde se escalan medidas quirúrgicas. La placenta ya fue expulsada, por lo que no es retención.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 38

Tema: Cardiopatías congénitas – Comunicación interventricular (Pediatría)

Lactante de 3 meses con diaforesis al alimentarse, pobre ganancia ponderal y taquipnea. A la auscultación presenta soplo holosistólico en borde esternal izquierdo inferior. Rx muestra cardiomegalia y aumento de flujo pulmonar.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Tetralogía de Fallot
B) Comunicación interauricular
C) Comunicación interventricular*
D) Persistencia del conducto arterioso
E) Coartación aórtica

Pregunta 2. Complicación más frecuente si no se trata:
A) Hipertensión pulmonar irreversible*
B) Endocarditis aislada
C) Arritmia supraventricular
D) Cianosis neonatal
E) Shock cardiogénico temprano

Retroalimentación:
Soplo holosistólico en borde esternal izquierdo con datos de hiperflujo pulmonar es característico de CIV. Las comunicaciones grandes pueden evolucionar a hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger si no se corrigen. La tetralogía produce cianosis, lo cual no se describe en este caso.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 39

Tema: Urología P2 – Hiperplasia prostática benigna

Hombre de 68 años con chorro urinario débil, nicturia y sensación de vaciamiento incompleto. Tacto rectal: próstata aumentada de tamaño, lisa y elástica. PSA 2.5 ng/ml. No hematuria.

Pregunta 1. Tratamiento inicial más adecuado:
A) Prostatectomía radical
B) Finasteride
C) Alfa bloqueador (tamsulosina)*
D) Radioterapia
E) Observación obligatoria

Pregunta 2. Mecanismo de acción principal del tratamiento elegido:
A) Disminuye tamaño prostático directamente
B) Relaja músculo liso prostático y vesical*
C) Inhibe producción de testosterona
D) Bloquea receptores muscarínicos
E) Disminuye PSA

Retroalimentación:
En síntomas moderados sin complicaciones, la GPC de HBP recomienda alfa bloqueadores como primera línea por su efecto rápido al relajar músculo liso prostático. Los inhibidores de 5-alfa reductasa reducen tamaño, pero su efecto es

más lento y se indican en próstatas muy grandes. PSA normal y tacto no sospechoso descartan cáncer.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 40

Tema: Neurología – Evento vascular cerebral isquémico

Mujer de 70 años con fibrilación auricular sin anticoagulación presenta hemiparesia izquierda súbita y desviación de mirada a la derecha. Inicio hace 2 horas. TA 150/90 mmHg. TAC simple sin hemorragia.

Pregunta 1. Conducta inmediata:
A) Aspirina oral
B) Trombolisis con alteplasa*
C) Heparina IV
D) Observación 24 h
E) Control estricto de TA <120 mmHg

Pregunta 2. Mecanismo fisiopatológico más probable:
A) Trombosis aterosclerótica
B) Embolia cardiogénica*
C) Hemorragia intracerebral
D) Vasculitis cerebral
E) Migraña complicada

Retroalimentación:
Paciente en ventana terapéutica (<4.5 h) sin hemorragia en TAC es candidata a trombólisis según GPC de EVC isquémico. La fibrilación auricular es causa frecuente de embolia cardiogénica. No se debe bajar la TA agresivamente antes de trombólisis salvo cifras >185/110 mmHg.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 41

Tema: Infectología – Tuberculosis pulmonar

Hombre de 39 años, pérdida de peso de 6 kg en 2 meses, tos productiva con hemoptisis ocasional y sudoración nocturna. Vive con 3 personas en casa pequeña.

Rx de tórax muestra infiltrado apical derecho con cavitación. Baciloscopía seriada positiva.

Pregunta 1. ¿Cuál es el esquema inicial indicado?
A) Isoniazida y rifampicina por 6 meses
B) Isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol fase intensiva*
C) Rifampicina sola
D) Levofloxacino
E) Observación

Pregunta 2. Duración total estándar del tratamiento en caso sensible:
A) 3 meses
B) 4 meses
C) 6 meses*
D) 9 meses
E) 12 meses

Retroalimentación:
La GPC de tuberculosis pulmonar indica esquema acortado estrictamente supervisado con fase intensiva de 2 meses (HRZE) seguida de fase de sostén con HR hasta completar 6 meses en casos sensibles. Monoterapia está contraindicada por riesgo de resistencia.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 42

Tema: VIH/SIDA – Profilaxis en paciente con CD4 bajo

Hombre de 32 años recién diagnosticado con VIH. CD4: 120 células/mm^3. Carga viral elevada. No síntomas respiratorios. No tratamiento previo.

Pregunta. ¿Qué profilaxis debe iniciarse además de TAR?
A) Isoniazida
B) Trimetoprim-sulfametoxazol*
C) Azitromicina
D) Fluconazol
E) Ninguna

Retroalimentación:
Con CD4 <200 células/mm^3 debe iniciarse profilaxis para Pneumocystis jirovecii con

trimetoprim-sulfametoxazol según GPC de VIH. La profilaxis para Mycobacterium avium se indica cuando CD4 <50. La isoniazida es para infección latente tuberculosa documentada.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 43

Tema: Enfermedades transmitidas por vector – Dengue

Mujer de 25 años con fiebre de 4 días, mialgias intensas, cefalea retroocular y exantema. Vive en zona endémica. Laboratorio: plaquetas 95,000, hematocrito elevado respecto a basal. Dolor abdominal leve.

Pregunta 1. ¿Qué dato indica probable progresión a dengue con signos de alarma?
A) Exantema
B) Fiebre
C) Hemoconcentración*
D) Cefalea
E) Mialgia

Pregunta 2. Conducta adecuada en este momento:
A) AINE
B) Alta con ibuprofeno
C) Vigilancia estrecha e hidratación controlada*
D) Corticoides
E) Antibiótico

Retroalimentación:
La hemoconcentración y trombocitopenia indican extravasación plasmática, signo de alarma según GPC de dengue. Debe vigilarse estrechamente y mantener hidratación adecuada. Los AINE están contraindicados por riesgo hemorrágico.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 44

Tema: Zoonosis – Tétanos

Hombre de 50 años sufre herida punzante con clavo oxidado. No recuerda última vacuna. A los días presenta trismus, rigidez muscular generalizada y espasmos dolorosos.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Botulismo
B) Rabia
C) Tétanos generalizado*
D) Meningitis
E) Hipocalcemia

Pregunta 2. Manejo inicial incluye:
A) Solo antibiótico
B) Inmunoglobulina antitetánica + metronidazol*
C) Penicilina oral
D) Observación
E) Vacuna únicamente

Retroalimentación:
Rigidez y trismus tras herida contaminada sugieren tétanos. El manejo incluye inmunoglobulina antitetánica para neutralizar toxina libre, antibiótico (metronidazol) y soporte. La vacuna sola no trata la enfermedad activa.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 45

Tema: Geriatría – Síndrome confusional agudo (Delirium)

Mujer de 82 años hospitalizada por neumonía comienza con desorientación fluctuante, alteración del ciclo sueño-vigilia y pensamiento incoherente. No antecedentes de demencia.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Demencia tipo Alzheimer
B) Depresión mayor
C) Delirium*
D) Psicosis primaria
E) Trastorno bipolar

Pregunta 2. Medida inicial más importante:
A) Haloperidol como único manejo
B) Identificar y tratar causa subyacente*
C) Sedación profunda
D) Antidepresivo
E) Alta hospitalaria

Retroalimentación:
Inicio agudo y curso fluctuante en contexto de enfermedad médica sugiere delirium. La GPC de síndromes geriátricos enfatiza identificar y corregir causa desencadenante (infección, fármacos, alteraciones metabólicas). Los antipsicóticos se reservan para agitación severa.

Grado de dificultad: Medio

CASO CLÍNICO 46

Tema: Psiquiatría – Trastorno depresivo mayor

Mujer de 29 años acude por 2 meses de ánimo deprimido la mayor parte del día, anhedonia, fatiga, hiporexia, insomnio de conciliación y sentimientos de inutilidad. Refiere dificultad para concentrarse en su trabajo. Niega consumo de sustancias. No antecedentes psiquiátricos. No ideación suicida activa.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Trastorno distímico
B) Trastorno depresivo mayor*
C) Trastorno bipolar II
D) Trastorno adaptativo
E) Duelo complicado

Pregunta 2. Tratamiento inicial de primera línea:
A) Haloperidol
B) Litio
C) ISRS*
D) Benzodiacepina en monoterapia
E) Valproato

Retroalimentación:
Cinco o más síntomas por más de 2 semanas con deterioro funcional cumplen criterios de episodio depresivo mayor. Las GPC recomiendan ISRS como tratamiento

farmacológico inicial en depresión moderada. Litio y valproato son para trastorno bipolar; benzodiacepinas no deben usarse como monoterapia.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 47

Tema: Dermatología – Melanoma cutáneo

Hombre de 61 años con lesión pigmentada en espalda que ha cambiado de tamaño y color en los últimos 6 meses. Bordes irregulares, diámetro 8 mm, asimétrica y con variación cromática. No dolor.

Pregunta 1. Criterio clínico que aumenta sospecha de malignidad:
A) Simetría
B) Diámetro <4 mm
C) Evolución reciente*
D) Color uniforme
E) Bordes regulares

Pregunta 2. Conducta diagnóstica correcta:
A) Crioterapia
B) Biopsia incisional superficial
C) Biopsia excisional con márgenes adecuados*
D) Antibiótico tópico
E) Observación 6 meses

Retroalimentación:
Los criterios ABCDE incluyen asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro >6 mm y evolución. La GPC recomienda biopsia excisional completa con márgenes para diagnóstico histopatológico. Procedimientos destructivos impiden evaluación adecuada.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 48

Tema: Hematología – Anemia ferropénica

Mujer de 34 años con fatiga y palidez. Menstruaciones abundantes. Hb 9 g/dL, VCM 70 fL, ferritina baja, TIBC elevado.

Pregunta 1. Tipo de anemia:
A) Normocítica
B) Macrocítica
C) Microcítica hipocrómica*
D) Hemolítica
E) Aplásica

Pregunta 2. Tratamiento inicial:
A) Hierro oral*
B) Transfusión inmediata
C) Eritropoyetina
D) Ácido fólico
E) Vitamina B12

Pregunta 3. Dato de laboratorio más específico para confirmar deficiencia de hierro:
A) VCM bajo
B) Ferritina sérica baja*
C) RDW elevado
D) Hb disminuida
E) Reticulocitos bajos

Retroalimentación:
La anemia ferropénica se caracteriza por microcitosis, hipocromía y ferritina baja, que es el marcador más específico de reservas disminuidas. El tratamiento inicial es hierro oral salvo intolerancia o anemia severa sintomática. Transfusión no es primera línea en paciente estable.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 49

Tema: Urgencias – Cetoacidosis diabética

Hombre de 22 años con DM1 que suspendió insulina. Presenta polidipsia, vómito y respiración profunda. Glucosa 420 mg/dL, pH 7.15, bicarbonato 10 mEq/L, cetonas positivas.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Estado hiperosmolar
B) Cetoacidosis diabética*

C) Hipoglucemia
D) Acidosis láctica aislada
E) Insuficiencia renal

Pregunta 2. Primera medida terapéutica:
A) Insulina en bolo inmediato
B) Bicarbonato IV
C) Líquidos IV con solución salina*
D) Suspender toda insulina
E) Glucosa IV

Retroalimentación:
Hiperglucemia con acidosis metabólica y cetonemia define cetoacidosis diabética. El manejo inicial según GPC es reposición vigorosa de líquidos con solución salina antes de iniciar insulina IV. Bicarbonato solo en acidosis severa (<6.9).

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 50

Tema: Ginecología – Embarazo ectópico

Mujer de 30 años con amenorrea de 7 semanas, dolor pélvico unilateral y manchado transvaginal. β-hCG positiva. USG transvaginal sin saco gestacional intrauterino y masa anexial derecha.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Aborto incompleto
B) Embarazo molar
C) Embarazo ectópico*
D) Quiste ovárico
E) Amenaza de aborto

Pregunta 2. Criterio para manejo con metotrexato:
A) Inestabilidad hemodinámica
B) Masa >5 cm
C) Paciente estable sin ruptura*
D) Hemoperitoneo
E) Hb <8 g/dL

Retroalimentación:
Ausencia de saco intrauterino con β-hCG positiva y masa anexial sugiere embarazo ectópico. El manejo médico con metotrexato está indicado en pacientes hemodinámicamente estables, sin ruptura y con criterios específicos de tamaño y niveles hormonales. La inestabilidad requiere manejo quirúrgico.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 51

Tema: Cirugía General – Apendicitis aguda complicada

Hombre de 27 años con 36 horas de dolor abdominal que inició periumbilical y migró a fosa iliaca derecha. Presenta fiebre de 38.5°C, náusea y vómito. A la exploración: defensa localizada, signo de rebote positivo. Leucocitos 18,000 con neutrofilia. TAC muestra apéndice dilatado con colección periapendicular de 4 cm.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Apendicitis simple
B) Apendicitis complicada con absceso*
C) Diverticulitis
D) Adenitis mesentérica
E) Íleo paralítico

Pregunta 2. Conducta más adecuada inicialmente:
A) Apendicectomía inmediata abierta
B) Antibióticos IV y drenaje percutáneo*
C) Alta con antibiótico oral
D) Observación 24 h
E) Colonoscopia

Retroalimentación:
En apendicitis complicada con absceso bien delimitado, las guías recomiendan manejo inicial conservador con antibióticos y drenaje percutáneo si es accesible. La cirugía inmediata aumenta riesgo de complicaciones. La apendicectomía diferida puede considerarse posteriormente.

Grado de dificultad: Alto

🩺 **CASO CLÍNICO 52**

Tema: Pediatría – Crisis asmática moderada

Niño de 8 años con antecedente de asma intermitente presenta disnea progresiva, sibilancias audibles, uso de músculos accesorios y saturación 91%. No cianosis. Puede hablar en frases cortas.

Pregunta 1. Clasificación de la crisis:
A) Leve
B) Moderada*
C) Grave
D) Paro respiratorio
E) Asma intermitente

Pregunta 2. Manejo inicial:
A) Antibiótico
B) Salbutamol inhalado + corticoide sistémico*
C) Solo oxígeno
D) Aminofilina
E) Intubación inmediata

Retroalimentación:
SatO2 90-94%, uso de músculos accesorios y habla en frases cortas corresponde a crisis moderada. El manejo según GPC incluye beta2 agonista inhalado de acción corta y corticoide sistémico temprano. La aminofilina no es de primera línea.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 53

Tema: Medicina Interna – Síndrome nefrótico

Hombre de 45 años con edema en miembros inferiores y párpados. Proteinuria 4.5 g/24h, albúmina 2.3 g/dL, colesterol elevado. Creatinina normal.

Pregunta 1. Diagnóstico sindromático:
A) Síndrome nefrítico
B) Síndrome nefrótico*
C) Insuficiencia renal aguda
D) Glomerulonefritis rápidamente progresiva
E) Pielonefritis

Pregunta 2. Complicación trombótica más frecuente:
A) TVP*

B) IAM
C) TEP séptico
D) Hemorragia cerebral
E) Endocarditis

Pregunta 3. Medida terapéutica general indicada:
A) Restricción proteica severa
B) IECA o ARA II*
C) Suspender lípidos
D) Antibiótico profiláctico
E) Hemodiálisis inmediata

Retroalimentación:
Proteinuria >3.5 g/día, hipoalbuminemia e hiperlipidemia definen síndrome nefrótico. Existe estado de hipercoagulabilidad con riesgo de trombosis venosa profunda. IECA/ARA II reducen proteinuria y protegen función renal. No se indica restricción proteica extrema.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 54

Tema: Cardiología – Síndrome coronario agudo con elevación del ST

Hombre de 58 años con dolor opresivo retroesternal de 1 hora de evolución irradiado a brazo izquierdo. ECG: elevación del ST en DII, DIII y aVF. TA 100/70 mmHg.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Angina inestable
B) IAM sin elevación ST
C) IAM con elevación ST inferior*
D) Pericarditis
E) Disección aórtica

Pregunta 2. Conducta prioritaria si hay sala de hemodinamia disponible:
A) Fibrinólisis
B) Angioplastia primaria*
C) Aspirina únicamente
D) Observación
E) Betabloqueador aislado

Retroalimentación:
Elevación del ST en derivaciones inferiores indica IAMCEST inferior. Si existe disponibilidad, la angioplastia primaria es tratamiento de elección según GPC, idealmente dentro de los primeros 90 minutos. La fibrinólisis se reserva cuando no hay acceso oportuno a hemodinamia.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 55

Tema: Obstetricia – Preeclampsia con criterios de severidad

Primigesta de 34 semanas con cefalea intensa, fosfenos y edema. TA 170/110 mmHg en dos mediciones. Proteinuria 3+. Plaquetas 95,000.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Hipertensión gestacional
B) Preeclampsia leve
C) Preeclampsia con criterios de severidad*
D) Eclampsia
E) HELLP aislado

Pregunta 2. Manejo inicial prioritario:
A) Observación ambulatoria
B) Sulfato de magnesio*
C) Diurético
D) IECA
E) Alta

Pregunta 3. Conducta obstétrica definitiva:
A) Prolongar embarazo hasta 40 semanas
B) Interrupción del embarazo tras estabilización*
C) Reposo domiciliario
D) Tocolisis
E) Indometacina

Retroalimentación:
TA ≥160/110, trombocitopenia y síntomas neurológicos son criterios de severidad. El manejo incluye sulfato de magnesio para prevención de convulsiones y control de TA, seguido de interrupción del embarazo tras estabilización materna, independientemente de edad gestacional ≥34 semanas.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 56

Tema: Medicina Crítica – Choque séptico

Hombre de 66 años con DM2 e hipertensión acude por fiebre, disuria y deterioro del estado de alerta. TA 82/50 mmHg, FC 120 lpm, FR 28 rpm, Temp 39°C. Lactato 4.8 mmol/L. Leucocitosis con neutrofilia. EGO con piuria abundante.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Sepsis
B) Choque hipovolémico
C) Choque séptico*
D) Choque cardiogénico
E) SIRS sin infección

Pregunta 2. Primera intervención terapéutica:
A) Vasopresor inmediato sin líquidos
B) Cristaloides IV 30 ml/kg*
C) Corticoide en bolo
D) Diurético IV
E) Transfusión

Pregunta 3. Vasopresor de primera línea si persiste hipotensión:
A) Dopamina
B) Adrenalina
C) Noradrenalina*
D) Fenilefrina
E) Vasopresina como único fármaco

Retroalimentación:
Hipotensión persistente con lactato elevado en contexto infeccioso define choque séptico. El manejo inicial según guías incluye reposición con cristaloides 30 ml/kg en la primera hora. Si persiste hipotensión, el vasopresor de elección es noradrenalina. Los vasopresores nunca sustituyen la reanimación con líquidos.

Grado de dificultad: Alto

🩺 **CASO CLÍNICO 57**

Tema: Gastroenterología – Pancreatitis aguda grave

Hombre de 48 años con dolor epigástrico intenso irradiado a espalda posterior a ingesta alcohólica. Lipasa 5 veces el límite superior. A las 48 horas presenta hipotensión, creatinina elevada y PaO2 55 mmHg.

Pregunta 1. Criterio que define gravedad:
A) Dolor intenso
B) Lipasa elevada
C) Falla orgánica persistente*
D) Náusea
E) Leucocitosis

Pregunta 2. Estudio indicado para valorar complicaciones locales después de 72 h:
A) USG simple
B) TAC contrastada*
C) CPRE inmediata
D) Endoscopia
E) Colonoscopia

Retroalimentación:
La pancreatitis grave se define por falla orgánica persistente (>48 h). La TAC contrastada se recomienda tras 72 horas para evaluar necrosis o complicaciones locales. La elevación de lipasa no determina gravedad.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 58

Tema: Neurología – Meningitis bacteriana aguda

Mujer de 19 años con fiebre, cefalea intensa y rigidez de nuca. Presenta fotofobia y vómito. TA estable. No focalización neurológica.

Pregunta 1. Conducta inmediata:
A) Esperar TAC
B) Punción lumbar inmediata*
C) Solo antibiótico oral
D) Observación
E) EEG

Pregunta 2. Tratamiento empírico inicial en adulto joven:
A) Ceftriaxona + vancomicina*
B) Amoxicilina
C) Ciprofloxacino
D) Metronidazol
E) Aciclovir únicamente

Retroalimentación:
En ausencia de datos de hipertensión intracraneal o focalización, se realiza punción lumbar inmediata. El tratamiento empírico en adultos jóvenes incluye ceftriaxona más vancomicina para cubrir neumococo resistente y meningococo, según guías nacionales.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 59

Tema: Trastornos ácido-base – Acidosis metabólica con anión gap elevado

Paciente masculino con antecedente de alcoholismo crónico acude con vómito y confusión. Gasometría: pH 7.25, HCO_3 12 mEq/L, $PaCO_2$ 25 mmHg. Na 140, Cl 100.

Pregunta 1. Trastorno principal:
A) Alcalosis metabólica
B) Acidosis metabólica con anión gap elevado*
C) Acidosis respiratoria
D) Alcalosis respiratoria
E) Mixto metabólico-respiratorio alcalino

Pregunta 2. Causa más probable en este contexto:
A) Diarrea
B) Cetoacidosis alcohólica*
C) Insuficiencia renal crónica
D) Hiperaldosteronismo
E) Vómito aislado

Retroalimentación:
Anión gap = 140 – (100 + 12) = 28, elevado. Con antecedente de alcoholismo y vómito, la causa probable es cetoacidosis alcohólica. La compensación respiratoria es adecuada según fórmula de Winter. La diarrea produce acidosis hiperclorémica con gap normal.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 60

Tema: Endocrinología – Tormenta tiroidea

Mujer de 35 años con antecedente de hipertiroidismo mal controlado presenta fiebre 40°C, taquicardia 150 lpm, agitación y vómito posterior a infección respiratoria.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Crisis de ansiedad
B) Tormenta tiroidea*
C) Feocromocitoma
D) Sepsis aislada
E) Meningitis

Pregunta 2. Manejo inicial correcto:
A) Levotiroxina
B) Metimazol + propranolol + esteroide*
C) Solo antibiótico
D) Yodo radiactivo inmediato
E) Observación

Retroalimentación:
Fiebre alta, taquicardia extrema y alteración neurológica en paciente hipertiroidea sugieren tormenta tiroidea. El manejo incluye betabloqueador, antitiroideo (metimazol o PTU), esteroide y posteriormente yodo. El yodo nunca se administra antes del antitiroideo.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 61

Tema: Cirugía General – Obstrucción intestinal mecánica

Hombre de 72 años con antecedente de laparotomía por úlcera perforada hace 10 años. Acude por dolor abdominal tipo cólico, distensión progresiva, vómito fecaloide y ausencia de evacuaciones y gases desde hace 24 horas. TA 110/70 mmHg, FC 105 lpm. Abdomen distendido, timpanismo generalizado, ruidos aumentados en tono metálico. Rx muestra niveles hidroaéreos múltiples y dilatación de asas de intestino delgado.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Íleo paralítico
B) Obstrucción intestinal por adherencias*
C) Vólvulo sigmoideo
D) Colitis isquémica
E) Pancreatitis aguda

Pregunta 2. Dato que sugiere complicación isquémica:
A) Dolor tipo cólico
B) Vómito
C) Leucocitosis y dolor continuo intenso*
D) Distensión
E) Antecedente quirúrgico

Pregunta 3. Conducta inicial en paciente estable sin datos de isquemia:
A) Laparotomía inmediata
B) Sonda nasogástrica + líquidos IV*
C) Colonoscopia
D) Antibiótico oral y alta
E) Enema evacuante

Retroalimentación:
Antecedente quirúrgico sugiere adherencias como causa más frecuente. En ausencia de datos de estrangulación, el manejo inicial es conservador con descompresión y reposición hídrica. Dolor continuo, fiebre o leucocitosis progresiva sugieren isquemia y requieren cirugía urgente.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 62

Tema: Ginecología – Hemorragia uterina anormal en perimenopausia

Mujer de 48 años con sangrado uterino abundante e irregular desde hace 6 meses. IMC 33 kg/m^2, nuligesta. USG transvaginal: endometrio de 16 mm. Hb 10 g/dL.

Pregunta 1. Factor de riesgo principal para patología endometrial maligna:
A) Edad <40
B) Obesidad*
C) Multiparidad

D) Uso de AINE
E) Ejercicio

Pregunta 2. Estudio diagnóstico indicado:
A) CA-125
B) Biopsia endometrial*
C) Histerectomía inmediata
D) TAC abdominal
E) Solo control en 6 meses

Retroalimentación:
Obesidad genera hiperestrogenismo por aromatización periférica, aumentando riesgo de hiperplasia y cáncer endometrial. En mujeres >45 años con sangrado anormal está indicada biopsia endometrial para descartar malignidad según guías.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 63

Tema: Cardiología – Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida

Hombre de 64 años con antecedente de IAM previo, disnea de pequeños esfuerzos y ortopnea. Ecocardiograma con FEVI 30%. TA 130/80 mmHg, creatinina normal.

Pregunta 1. Grupo farmacológico que reduce mortalidad:
A) Diuréticos aislados
B) IECA o ARA II*
C) Digoxina sola
D) Nitratos
E) Calcioantagonistas no dihidropiridínicos

Pregunta 2. Fármaco que debe evitarse por empeorar función sistólica:
A) Metoprolol
B) Espironolactona
C) Verapamilo*
D) Sacubitril/valsartán
E) Enalapril

Retroalimentación:
En IC con FE reducida, IECA/ARA II, betabloqueadores y antagonistas de aldosterona

reducen mortalidad. Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos como verapamilo pueden deprimir la contractilidad y no están indicados en FE reducida.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 64

Tema: Pediatría – Sepsis neonatal temprana

Recién nacido de 38 semanas, madre con ruptura prolongada de membranas 22 horas y fiebre intraparto. A las 12 horas de vida presenta dificultad respiratoria, letargia y mala perfusión.

Pregunta 1. Factor de riesgo más importante en este caso:
A) Cesárea
B) Ruptura prolongada de membranas*
C) Edad materna
D) Sexo masculino
E) Peso adecuado

Pregunta 2. Manejo empírico inicial:
A) Ceftriaxona sola
B) Ampicilina + aminoglucósido*
C) Observación
D) Macrólido
E) Antiviral

Retroalimentación:
Ruptura prolongada de membranas y fiebre materna son factores clave para sepsis neonatal temprana. El esquema empírico recomendado es ampicilina más aminoglucósido para cubrir estreptococo del grupo B y gramnegativos.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 65

Tema: Nefrología – Hiponatremia sintomática

Mujer de 70 años con antecedente de uso reciente de diurético tiazídico presenta somnolencia y náusea. Na sérico 118 mEq/L. Osmolaridad plasmática baja.

Pregunta 1. Tipo de hiponatremia:
A) Hipertónica
B) Isotónica
C) Hipotónica*
D) Pseudohiponatremia
E) Secundaria a hiperglucemia

Pregunta 2. Manejo en presencia de síntomas neurológicos:
A) Restricción hídrica exclusiva
B) Solución salina hipertónica 3% en bolo controlado*
C) Solución glucosada
D) Diurético de asa
E) Observación

Retroalimentación:
Sodio <120 con síntomas neurológicos requiere corrección cuidadosa con solución hipertónica al 3% para evitar edema cerebral. La corrección no debe exceder límites seguros para prevenir mielinolisis pontina. Las tiazidas son causa frecuente de hiponatremia en adultos mayores.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 66

Tema: Medicina Interna – Tromboembolia pulmonar

Mujer de 42 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por disnea súbita y dolor torácico pleurítico. FC 118 lpm, TA 110/70 mmHg, $SatO_2$ 89%. Dímero D elevado. Angiotomografía muestra defecto de llenado en arteria pulmonar segmentaria derecha.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Neumonía
B) Infarto agudo de miocardio
C) Tromboembolia pulmonar*
D) Derrame pleural
E) Pericarditis

Pregunta 2. Manejo inicial en paciente hemodinámicamente estable:
A) Trombólisis inmediata
B) Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular*
C) Filtro de vena cava

D) Aspirina
E) Alta con AINE

Pregunta 3. Indicador de trombólisis sistémica:
A) $SatO_2$ <90%
B) Dolor torácico
C) Hipotensión sostenida*
D) Uso de anticonceptivos
E) Dímero D elevado

Retroalimentación:
En TEP estable el manejo inicial es anticoagulación. La trombólisis se reserva para TEP de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica (hipotensión sostenida o choque). El dímero D no define gravedad.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 67

Tema: Gastroenterología – Hemorragia digestiva alta

Hombre de 55 años con antecedente de cirrosis alcohólica presenta hematemesis abundante y melena. TA 90/60 mmHg, FC 120 lpm.

Pregunta 1. Causa más probable:
A) Úlcera gástrica
B) Varices esofágicas*
C) Mallory-Weiss
D) Gastritis erosiva
E) Cáncer gástrico

Pregunta 2. Manejo farmacológico inicial además de reanimación:
A) Omeprazol únicamente
B) Octreótido IV*
C) AINE
D) Antiácido oral
E) Metoclopramida

Retroalimentación:
En paciente cirrótico con hematemesis masiva se debe sospechar sangrado variceal.

El manejo incluye reanimación, octreótido IV y antibiótico profiláctico, seguido de endoscopia urgente. Los IBP solos no son suficientes en sospecha variceal.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 68

Tema: Endocrinología – Síndrome de Cushing

Mujer de 38 años con obesidad central, cara redondeada, equimosis fácil y debilidad proximal. TA 150/95 mmHg. Cortisol libre urinario elevado.

Pregunta 1. Estudio inicial para confirmar hipercortisolismo:
A) Cortisol sérico matutino
B) Cortisol libre urinario 24 h*
C) ACTH basal
D) TSH
E) TAC abdominal

Pregunta 2. Si ACTH está suprimida, la causa más probable es:
A) Adenoma hipofisario
B) Tumor suprarrenal*
C) Producción ectópica de ACTH
D) Estrés
E) Depresión

Retroalimentación:
El diagnóstico inicial de hipercortisolismo se realiza con cortisol libre urinario de 24 horas o prueba de supresión con dexametasona. ACTH baja orienta a origen suprarrenal autónomo; ACTH elevada sugiere causa hipofisaria o ectópica.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 69

Tema: Obstetricia – Trabajo de parto pretérmino

Gestante de 32 semanas con contracciones regulares cada 5 minutos y dilatación cervical de 3 cm. Membranas íntegras. Sin datos de infección.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Amenaza de aborto
B) Trabajo de parto pretérmino*
C) Ruptura prematura de membranas
D) Falso trabajo de parto
E) Placenta previa

Pregunta 2. Manejo indicado:
A) Inducir parto inmediato
B) Tocolítico + corticoide antenatal*
C) IECA
D) Antibiótico rutinario
E) Alta sin manejo

Retroalimentación:
Contracciones regulares con cambios cervicales antes de 37 semanas definen trabajo de parto pretérmino. El manejo incluye tocolíticos para retrasar parto y permitir administración de corticoides antenatales para maduración pulmonar fetal.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 70

Tema: Neurología – Hemorragia subaracnoidea

Mujer de 50 años con cefalea súbita "en trueno", la peor de su vida, acompañada de vómito y rigidez de nuca. TAC muestra sangre en espacio subaracnoideo.

Pregunta 1. Causa más frecuente:
A) Trauma
B) Aneurisma sacular roto*
C) MAV
D) Trombosis venosa
E) Tumor cerebral

Pregunta 2. Medicamento para prevenir vasoespasmo cerebral:
A) Dexametasona
B) Nimodipino*
C) Manitol
D) Furosemida
E) Aspirina

Retroalimentación:
La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática es ruptura de aneurisma sacular. El nimodipino reduce riesgo de vasoespasmo cerebral y mejora pronóstico neurológico según guías internacionales y nacionales.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 71

Tema: Medicina Interna – Estado hiperosmolar hiperglucémico

Hombre de 68 años con DM2 mal controlada es traído por confusión progresiva. Refiere poliuria y polidipsia desde hace una semana. TA 95/60 mmHg, FC 110 lpm. Glucosa 780 mg/dL, pH 7.38, bicarbonato 22 mEq/L, cetonas negativas, osmolaridad plasmática elevada.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Cetoacidosis diabética
B) Estado hiperosmolar hiperglucémico*
C) Hipoglucemia severa
D) Acidosis láctica
E) Síndrome urémico

Pregunta 2. Diferencia clave respecto a cetoacidosis diabética:
A) Glucosa menor
B) Presencia de cetonas
C) Ausencia de acidosis metabólica significativa*
D) Edad joven
E) Inicio súbito

Pregunta 3. Manejo inicial prioritario:
A) Insulina en bolo alto inmediato
B) Líquidos IV con solución salina isotónica*
C) Bicarbonato IV
D) Diurético
E) Glucosa IV

Retroalimentación:
Glucosa >600 mg/dL, osmolaridad elevada y ausencia de acidosis significativa definen estado hiperosmolar. El tratamiento inicial es reposición vigorosa de líquidos antes de iniciar insulina. La acidosis y cetonemia marcan la diferencia con cetoacidosis.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 72

Tema: Cirugía – Colecistitis aguda

Mujer de 44 años con dolor en hipocondrio derecho de 24 horas, fiebre y náusea. Signo de Murphy positivo. USG: vesícula con pared engrosada y lito impactado en cuello vesicular.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Colelitiasis asintomática
B) Colecistitis aguda calculosa*
C) Colangitis
D) Hepatitis viral
E) Pancreatitis

Pregunta 2. Manejo definitivo recomendado:
A) Antibiótico exclusivo
B) Colecistectomía laparoscópica temprana*
C) Litotricia
D) CPRE inmediata
E) Observación

Retroalimentación:
Dolor en hipocondrio derecho, Murphy positivo y hallazgos ecográficos confirman colecistitis aguda. La conducta recomendada es colecistectomía laparoscópica temprana durante el mismo internamiento. El manejo conservador aislado aumenta recurrencias.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 73

Tema: Hematología – Púrpura trombocitopénica inmune

Mujer de 26 años con petequias y equimosis espontáneas. Plaquetas 18,000/mm^3. Hb y leucocitos normales. No esplenomegalia.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Leucemia aguda

B) Púrpura trombocitopénica inmune*
C) CID
D) Aplasia medular
E) Dengue

Pregunta 2. Tratamiento inicial en paciente sintomática:
A) Transfusión de eritrocitos
B) Corticoesteroide sistémico*
C) Esplenectomía inmediata
D) Antibiótico
E) Observación sin manejo

Retroalimentación:
Trombocitopenia aislada con resto de biometría normal sugiere PTI. El tratamiento inicial en casos con plaquetas <30,000 o sangrado es corticoesteroide. La esplenectomía se reserva para casos refractarios.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 74

Tema: Obstetricia – Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Gestante de 36 semanas con dolor abdominal súbito, útero hipertónico y sangrado vaginal oscuro. FCF con desaceleraciones tardías.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Placenta previa
B) Ruptura uterina
C) Desprendimiento prematuro de placenta*
D) Trabajo de parto normal
E) Vasa previa

Pregunta 2. Característica clínica típica:
A) Sangrado indoloro
B) Útero blando
C) Dolor intenso y útero hipertónico*
D) Ausencia de sangrado
E) Presentación podálica

Pregunta 3. Conducta en caso de compromiso fetal:
A) Observación
B) Cesárea urgente*
C) Tocolisis
D) Alta
E) Antibiótico

Retroalimentación:
Dolor intenso, sangrado oscuro y útero hipertónico caracterizan DPPNI. A diferencia de placenta previa (sangrado rojo brillante e indoloro). Si existe compromiso fetal, se indica interrupción inmediata del embarazo.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 75

Tema: Infectología – Endocarditis infecciosa

Hombre de 60 años con antecedente de valvulopatía presenta fiebre persistente, pérdida de peso y soplo nuevo. Hemocultivos positivos para Streptococcus viridans.

Pregunta 1. Criterio mayor de Duke presente:
A) Fiebre
B) Soplo
C) Hemocultivos positivos típicos*
D) Anemia
E) Petequias

Pregunta 2. Estudio de imagen indicado para confirmar vegetaciones:
A) ECG
B) Eco transtorácico
C) Ecocardiograma transesofágico*
D) TAC torácico
E) Rx de tórax

Retroalimentación:
Hemocultivos positivos para microorganismo típico constituyen criterio mayor de Duke. El ecocardiograma transesofágico tiene mayor sensibilidad para detectar vegetaciones, especialmente en válvulas nativas o prótesis.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 76

Tema: Trastornos ácido–base mixtos

Hombre de 30 años con antecedente de DM1 acude por vómito intenso y respiración profunda. Gasometría: pH 7.48, HCO_3 18 mEq/L, $PaCO_2$ 25 mmHg. Na 138, Cl 100.

Pregunta 1. Trastorno primario:
A) Alcalosis metabólica
B) Alcalosis respiratoria
C) Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria concomitante*
D) Acidosis respiratoria
E) Normal

Pregunta 2. ¿Existe trastorno mixto?
A) No
B) Sí, acidosis metabólica + alcalosis respiratoria*
C) Sí, alcalosis metabólica + acidosis respiratoria
D) Solo compensación normal
E) Solo acidosis respiratoria

Retroalimentación:
Hay alcalemia (pH 7.48) con HCO_3 bajo y $PaCO_2$ bajo. El anión gap es 138-(100+18)=20 (elevado), lo que indica acidosis metabólica. El pH alcalino sugiere alcalosis respiratoria concomitante, no simple compensación. Esto es típico en cetoacidosis con hiperventilación marcada.

Grado de dificultad: Alto

🩺 **CASO CLÍNICO 77**

Tema: Nefrología – Lesión renal aguda prerrenal

Mujer de 75 años con diarrea abundante por 4 días. TA 85/55 mmHg. Creatinina aumenta de 0.9 a 2.1 mg/dL. EGO sin cilindros patológicos. FeNa 0.5%.

Pregunta 1. Tipo de lesión renal:
A) Intrínseca
B) Posrenal
C) Prerrenal*
D) Necrosis tubular establecida
E) Glomerulonefritis

Pregunta 2. Dato que apoya origen prerrenal:
A) FeNa >2%
B) Cilindros granulosos
C) FeNa <1%*
D) Proteinuria masiva
E) Hematuria dismórfica

Retroalimentación:
Hipovolemia con FeNa <1% indica riñón funcionalmente intacto con retención de sodio, compatible con lesión prerrenal. La necrosis tubular aguda típicamente presenta FeNa >2% y cilindros granulosos.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 78

Tema: Endocrinología – Hiperpotasemia

Hombre de 62 años con ERC estadio 4 acude por debilidad muscular. K sérico 6.8 mEq/L. ECG con ondas T picudas y QRS ligeramente ensanchado.

Pregunta 1. Medida inmediata para estabilizar membrana miocárdica:
A) Insulina con glucosa
B) Salbutamol
C) Gluconato de calcio IV*
D) Furosemida
E) Resina de intercambio

Pregunta 2. Tratamiento para reducir potasio sérico rápidamente (transitorio):
A) Calcio
B) Insulina + glucosa*
C) Hemodiálisis inmediata
D) Dieta baja en potasio
E) Restricción hídrica

Retroalimentación:
En hiperpotasemia con cambios ECG se administra primero gluconato de calcio para estabilizar membrana. Posteriormente se emplean medidas que desplazan potasio al interior celular como insulina con glucosa. La hemodiálisis elimina potasio pero no es la primera medida inmediata salvo refractariedad.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 79

Tema: Endocrinología – Hipercalcemia primaria

Mujer de 55 años con litiasis renal recurrente y estreñimiento. Calcio 11.8 mg/dL, PTH elevada.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Hipercalcemia por malignidad
B) Hiperparatiroidismo primario*
C) Intoxicación por vitamina D
D) Sarcoidosis
E) Mieloma múltiple

Pregunta 2. Tratamiento definitivo:
A) Hidratación permanente
B) Bifosfonato crónico
C) Paratiroidectomía*
D) Diurético tiazídico
E) Corticoide

Retroalimentación:
Hipercalcemia con PTH elevada es compatible con hiperparatiroidismo primario. El tratamiento definitivo en pacientes sintomáticos es quirúrgico. En hipercalcemia por malignidad la PTH estaría suprimida.

Grado de dificultad: Medio

🩺 CASO CLÍNICO 80

Tema: Medicina Interna – Síndrome nefrítico agudo

Hombre de 18 años con antecedente de faringitis hace 2 semanas presenta edema facial, hematuria y TA 150/95 mmHg. Creatinina ligeramente elevada.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Síndrome nefrótico
B) Glomerulonefritis postestreptocócica*
C) Nefropatía diabética

D) Pielonefritis
E) Litiasis renal

Pregunta 2. Dato inmunológico característico:
A) C3 elevado
B) C3 disminuido*
C) ANA positivo
D) ANCA positivo
E) Anti-GBM positivo

Pregunta 3. Manejo general:
A) Antibiótico prolongado obligatorio
B) Inmunosupresor inmediato
C) Manejo de soporte y control de TA*
D) Hemodiálisis en todos
E) Cirugía

Retroalimentación:
Hematuria, hipertensión y edema tras infección estreptocócica sugieren glomerulonefritis postestreptocócica, caracterizada por consumo de complemento (C3 bajo). El tratamiento es principalmente de soporte, control de presión y volumen.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 81

Tema: Medicina Crítica – Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)

Hombre de 54 años, antecedente de DM2 e hipertensión, ingresa por neumonía adquirida en la comunidad confirmada por infiltrado lobar derecho y leucocitosis. A las 48 horas presenta deterioro respiratorio progresivo con disnea intensa, taquipnea de 34 rpm y saturación 82% con mascarilla reservorio a 15 L/min. Se decide intubación orotraqueal. Gasometría con FiO_2 100% muestra PaO_2 60 mmHg. Rx de tórax con infiltrados bilaterales difusos no explicados por falla cardiaca. Ecocardiograma sin datos de disfunción ventricular significativa.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Edema agudo cardiogénico
B) Tromboembolia pulmonar
C) Síndrome de dificultad respiratoria aguda*
D) Crisis asmática
E) Neumotórax bilateral

Pregunta 2. Criterio que confirma gravedad según Berlín:
A) PaO_2 <80 mmHg
B) Relación PaO_2/FiO_2 <100*
C) Necesidad de intubación
D) Hipercapnia
E) Leucocitosis

Pregunta 3. Estrategia ventilatoria recomendada:
A) Volúmenes corrientes altos para mejorar oxigenación
B) Volumen corriente bajo 6 ml/kg de peso ideal*
C) PEEP mínima
D) Hiperventilación agresiva
E) Suspender sedación

Retroalimentación:
SDRA se define por inicio agudo, infiltrados bilaterales y PaO_2/FiO_2 disminuida sin causa cardiogénica. Con PaO_2 60 y FiO_2 1.0, la relación es 60, compatible con SDRA grave. El manejo incluye ventilación protectora con volúmenes bajos (6 ml/kg peso ideal) para reducir lesión pulmonar inducida por ventilador.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 82

Tema: Gastroenterología – Pancreatitis aguda biliar con complicación sistémica

Mujer de 47 años con antecedente de colelitiasis presenta dolor epigástrico intenso irradiado a espalda, náusea y vómito. Lipasa 6 veces el límite normal. A las 24 horas desarrolla hipotensión leve, oliguria y creatinina en ascenso. Hematocrito elevado y BUN aumentado. USG muestra litos vesiculares sin dilatación de vía biliar.

Pregunta 1. Etiología más probable:
A) Alcohol
B) Biliar*
C) Hipertrigliceridemia
D) Fármaco
E) Idiopática

Pregunta 2. Dato que sugiere mayor gravedad:
A) Dolor intenso
B) Elevación de lipasa

C) Elevación de BUN y hematocrito*
D) Náusea
E) Fiebre

Pregunta 3. Conducta respecto a la vesícula biliar:
A) Colecistectomía diferida meses después
B) CPRE urgente en todos los casos
C) Colecistectomía durante mismo internamiento una vez estabilizada*
D) Ningún tratamiento quirúrgico
E) Litotricia

Retroalimentación:
La etiología biliar es la causa más frecuente. Elevación de BUN y hemoconcentración se asocian a mayor mortalidad. En pancreatitis biliar leve a moderada, la colecistectomía debe realizarse durante el mismo internamiento tras estabilización para evitar recurrencia.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 83

Tema: Neurología – Evento vascular cerebral isquémico y ventana terapéutica extendida

Hombre de 63 años con antecedente de fibrilación auricular sin anticoagulación es encontrado con hemiplejia derecha y afasia. Última vez visto sano hace 7 horas. TAC simple sin hemorragia. Angiotomografía muestra oclusión de arteria cerebral media izquierda proximal con tejido de penumbra viable en estudio de perfusión.

Pregunta 1. ¿Es candidato a trombólisis IV estándar?
A) Sí
B) No*
C) Solo si presión baja
D) Solo si glucosa normal
E) Sí sin importar tiempo

Pregunta 2. Conducta más adecuada:
A) Aspirina únicamente
B) Trombectomía mecánica*
C) Observación

D) Anticoagulación inmediata
E) Alta

Pregunta 3. Mecanismo fisiopatológico más probable:
A) Trombosis lacunar
B) Embolia cardiogénica*
C) Vasculitis
D) Disección carotídea
E) Migraña

Retroalimentación:
La trombólisis IV estándar tiene ventana hasta 4.5 horas. Sin embargo, en presencia de oclusión de gran vaso y penumbra viable, la trombectomía mecánica puede realizarse hasta 24 horas según criterios de imagen. Fibrilación auricular sugiere embolia cardiogénica.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 84

Tema: Obstetricia – Corioamnionitis

Gestante de 30 semanas con ruptura prematura de membranas desde hace 24 horas presenta fiebre 38.8°C, taquicardia materna y fetal, útero doloroso a la palpación y líquido amniótico fétido.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Trabajo de parto pretérmino simple
B) Corioamnionitis*
C) Placenta previa
D) DPPNI
E) ITU aislada

Pregunta 2. Manejo inicial indicado:
A) Tocolítico
B) Antibiótico IV de amplio espectro*
C) Reposo absoluto
D) Alta
E) Solo paracetamol

Pregunta 3. Conducta obstétrica:
A) Prolongar embarazo
B) Interrupción del embarazo tras estabilización*
C) Tocolisis prolongada
D) Esperar maduración pulmonar
E) Cerclaje

Retroalimentación:
Fiebre, taquicardia fetal y líquido fétido sugieren infección intraamniótica. El manejo incluye antibiótico IV inmediato y resolución del embarazo, ya que la infección contraindica prolongar gestación incluso en pretérmino.

Grado de dificultad: Alto

CASO CLÍNICO 85

Tema: Medicina Interna – Choque cardiogénico post IAM

Hombre de 62 años con antecedente de hipertensión y tabaquismo acude por dolor torácico opresivo de 3 horas de evolución. ECG con elevación del ST en V1–V4. Se realiza angioplastia primaria con reperfusión exitosa. A las 6 horas evoluciona con hipotensión (TA 78/50 mmHg), piel fría, oliguria y estertores bibasales. FC 120 lpm. Lactato elevado. Ecocardiograma muestra FEVI 25% con hipocinesia anterior extensa.

Pregunta 1. Diagnóstico actual:
A) Choque séptico
B) Choque hipovolémico
C) Choque cardiogénico*
D) Taponamiento cardiaco
E) Reinfarto inmediato

Pregunta 2. Manejo farmacológico inicial indicado:
A) Cristaloides en bolo amplio
B) Noradrenalina + inotrópico (dobutamina)*
C) Diurético exclusivo
D) Betabloqueador
E) IECA inmediato

Pregunta 3. Medida avanzada si no responde a manejo farmacológico:
A) Fibrinólisis
B) Balón de contrapulsación intraaórtico*

C) Antibiótico
D) Pericardiocentesis
E) Alta

Retroalimentación:
Hipotensión con bajo gasto posterior a IAM y FEVI severamente reducida define choque cardiogénico. El manejo incluye vasopresor (noradrenalina) para mantener perfusión e inotrópico como dobutamina para mejorar contractilidad. Si persiste inestabilidad, puede considerarse soporte mecánico como balón intraaórtico.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 86

Tema: Gastroenterología – Colangitis aguda

Mujer de 58 años con antecedente de colelitiasis acude por dolor en hipocondrio derecho, fiebre y ictericia progresiva. TA 95/60 mmHg, FC 115 lpm. Laboratorio con bilirrubina directa elevada y fosfatasa alcalina aumentada. USG con dilatación de vía biliar.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Hepatitis viral
B) Colecistitis
C) Colangitis aguda*
D) Pancreatitis
E) Absceso hepático

Pregunta 2. Tríada clásica presente en este caso:
A) Dolor, vómito y fiebre
B) Fiebre, ictericia y dolor en HD*
C) Ictericia, ascitis y edema
D) Fiebre, tos y disnea
E) Dolor, diarrea y fiebre

Pregunta 3. Conducta terapéutica definitiva urgente:
A) Colecistectomía inmediata
B) CPRE con drenaje biliar*
C) Antibiótico oral
D) Observación
E) Litotricia

Retroalimentación:
Dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia conforman la tríada de Charcot. La colangitis es una urgencia que requiere antibiótico IV y descompresión biliar urgente mediante CPRE. El retraso aumenta mortalidad.

Grado de dificultad: Alto

🩺 CASO CLÍNICO 87

Tema: Neurología – Estado epiléptico convulsivo

Hombre de 28 años sin antecedentes conocidos presenta crisis tónico-clónica generalizada que dura más de 7 minutos sin recuperación de conciencia. En urgencias continúa convulsionando.

Pregunta 1. Diagnóstico:
A) Crisis aislada
B) Estado epiléptico*
C) Síncope convulsivo
D) Trastorno psicógeno
E) Migraña

Pregunta 2. Manejo farmacológico inmediato:
A) Fenitoína IV como primera línea
B) Benzodiacepina IV (lorazepam)*
C) Haloperidol
D) Carbamazepina oral
E) Observación

Pregunta 3. Si persiste tras benzodiacepina:
A) Repetir indefinidamente benzodiacepina
B) Administrar antiepiléptico IV como levetiracetam o fenitoína*
C) Suspender tratamiento
D) Dar antidepresivo
E) Alta

Retroalimentación:
Crisis mayor a 5 minutos o repetidas sin recuperación define estado epiléptico. El manejo inicial es benzodiacepina IV. Si persiste, se administra antiepiléptico de segunda línea como levetiracetam o fenitoína. El tratamiento debe ser escalonado y rápido para evitar daño neurológico.

Grado de dificultad: Medio–Alto

🩺 CASO CLÍNICO 88

Tema: Obstetricia – Síndrome HELLP

Gestante de 35 semanas con antecedente de preeclampsia presenta dolor en epigastrio intenso, náusea y malestar general. TA 165/105 mmHg. Laboratorio: AST y ALT elevadas, plaquetas 75,000/mm^3, DHL elevada.

Pregunta 1. Diagnóstico más probable:
A) Hepatitis viral
B) Colestasis intrahepática
C) Síndrome HELLP*
D) Hígado graso agudo
E) Gastritis

Pregunta 2. Componente que define el síndrome:
A) Hipoglucemia
B) Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia*
C) Proteinuria aislada
D) Bilirrubina directa elevada
E) Anemia ferropénica

Pregunta 3. Conducta definitiva:
A) Observación ambulatoria
B) Interrupción del embarazo tras estabilización*
C) Solo antihipertensivo
D) Antibiótico
E) Tocolítico

Retroalimentación:
HELLP es variante grave de preeclampsia caracterizada por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Representa emergencia obstétrica y requiere estabilización materna e interrupción del embarazo.

Grado de dificultad: Alto

Tema: Trastornos Hipertensivos del Embarazo (Preeclampsia / Eclampsia).

Caso Clínico: Paciente primigesta de 19 años con 34.2 semanas de gestación por FUM confiable. Acude a urgencias por presentar cefalea pulsátil intensa, fosfenos y

dolor en hipocondrio derecho de 2 horas de evolución. A la exploración física se reporta TA 165/110 mmHg (confirmada a los 15 minutos), FC 88 lpm, FR 18 rpm. Se observa edema pretibial ++/+++. Los laboratorios muestran: Hemoglobina 11 g/dL, Plaquetas 105,000/mm^3, Creatinina 1.2 mg/dL, AST 85 U/L, ALT 90 U/L y proteinuria en tira reactiva +++. Se inicia esquema de Zuspan.

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el diagnóstico más preciso de acuerdo con los criterios actuales de la GPC? a) Preeclampsia sin datos de severidad. b) Hipertensión gestacional. c) *Preeclampsia con datos de severidad. d) Síndrome de HELLP.
2. ¿Cuál es la meta de presión arterial diastólica recomendada durante el manejo agudo para prevenir complicaciones cerebrovasculares? a) 90 - 100 mmHg. b) *80 - 105 mmHg. c) 70 - 90 mmHg. d) < 80 mmHg.

Retroalimentación: La paciente presenta criterios de severidad (TA >160/110 mmHg y síntomas neurológicos/viscerales). Según la GPC, el manejo hipertensivo agudo busca mantener la diastólica entre 80-105 mmHg para evitar hipoperfusión placentaria. El esquema de sulfato de magnesio (Zuspan) es mandatorio para prevención de eclampsia. **Grado de dificultad:** Medio

---

Caso Clínico 2

Tema: Estenosis Hipertrófica de Píloro.

Caso Clínico: Masculino de 3 semanas de vida, producto de la primera gesta, obtenido por parto eutócico sin complicaciones. Es traído a consulta por presentar vómito de contenido gástrico, no biliar, de tipo proyectil, inmediatamente después de cada tetada desde hace 4 días. La madre refiere que el niño se muestra "hambriento" tras vomitar. A la exploración física: peso 3,100g (peso al nacer 3,400g), fontanela anterior ligeramente deprimida, mucosas secas y se palpa una masa firme, móvil, de aproximadamente 2 cm en el cuadrante superior derecho del abdomen.

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico y ácido-base que espera encontrar con mayor probabilidad? a) Acidosis metabólica hiperclorémica e hipopotasemia. b) *Alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasemia. c) Alcalosis respiratoria compensada. d) Acidosis metabólica con brecha aniónica elevada.

2. ¿Cuál es el estudio de imagen de primera elección para confirmar el diagnóstico y qué hallazgo se espera encontrar? a) Serie esofagogastroduodenal / Signo del "pico de pájaro". b) Radiografía de abdomen / Imagen de "doble burbuja". c) *Ultrasonografía abdominal / Espesor del músculo pilórico >15-17 mm. d) Tomografía computarizada / Signo del "tiro al blanco".

Retroalimentación: La clínica de vómito proyectil no biliar y la oliva pilórica palpable son patognomónicos. La pérdida de hidrogeniones y cloro gástrico induce alcalosis metabólica e hipocloremia; la hipopotasemia ocurre por intercambio renal para retener protones. El USG es el estándar de oro inicial (músculo >4mm de espesor o longitud >17mm). **Grado de dificultad:** Alto

---

Caso Clínico 3

Tema: Cardiología: Cardiopatía Isquémica (Angina e Infarto).

Caso Clínico: Masculino de 62 años con antecedentes de DM2 de 15 años de evolución (mal control, HbA1c 9.5%) e HAS. Acude a urgencias por presentar cuadro de diaforesis profusa, náuseas y debilidad generalizada de 45 minutos de evolución. Refiere una ligera "opresión" en el pecho, pero enfatiza el malestar general. Al ingreso: TA 100/60 mmHg, FC 54 lpm. El ECG muestra elevación del segmento ST de 3 mm en las derivaciones II, III y aVF.

Preguntas e Incisos:

1. Ante la sospecha de extensión del infarto a ventrículo derecho, ¿cuál es la conducta diagnóstica inmediata más adecuada? a) Solicitar enzimas cardíacas (CPK-MB y Troponinas) seriadas. b) Realizar un ecocardiograma transtorácico de urgencia. c) *Realizar ECG con derivaciones precordiales derechas (V3R y V4R). d) Iniciar infusión de nitroglicerina de inmediato.
2. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección para la hipotensión en este paciente, considerando la localización del infarto? a) Furosemida IV. b) *Carga de líquidos (solución salina 0.9%). c) Dobutamina. d) Betabloqueadores orales.

Retroalimentación: El paciente presenta un IAMCEST de cara inferior. En diabéticos, los síntomas suelen ser atípicos (equivalentes anginosos). Ante un infarto inferior con bradicardia e hipotensión, se debe sospechar afección de ventrículo derecho; el uso

de nitratos está contraindicado por riesgo de colapso hemodinámico, siendo el pilar el aporte de volumen. **Grado de dificultad:** Alto

Caso Clínico 4

Tema: Oncología Ginecología P1: Cáncer de Endometrio y Ovario.

Caso Clínico: Femenina de 63 años, con antecedente de DM2 y obesidad grado II (IMC 36 kg/m^2), nuligesta. Acude por presentar sangrado transvaginal postmenopáusico de 2 semanas de evolución, escaso, de color achocolatado. Niega uso de terapia de reemplazo hormonal. A la exploración física no se palpan masas anexiales; cérvix de aspecto sano. Se realiza ultrasonido transvaginal que reporta un eco endometrial de 14 mm, de aspecto heterogéneo y con aumento de la vascularidad al Doppler.

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en esta paciente para el desarrollo de la patología sospechada? a) Nuliparidad. b) Diabetes Mellitus. c) *Exposición a estrógenos sin oposición (Obesidad). d) Edad avanzada.
2. De acuerdo con la GPC, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico definitivo en esta paciente? a) Citología cervical y legrado endocervical. b) *Biopsia de endometrio (preferentemente por histeroscopia). c) Aspiración manual endouterina (AMEU). d) Medición seriada de CA-125.

Retroalimentación: En toda paciente postmenopáusica con sangrado y un grosor endometrial >5 mm (o >3 mm según algunas guías estrictas), el cáncer de endometrio es la primera sospecha. La obesidad periférica convierte andrógenos en estrona (aromatización), generando una estimulación estrogénica crónica sin oposición de progesterona, siendo el principal factor de riesgo para el tipo I (adenocarcinoma). **Grado de dificultad:** Medio

---

Caso Clínico 5

Tema: Patología Respiratoria Neonatal (Membrana hialina, TTRN, SAM).

Caso Clínico: Recién nacido masculino de 39 semanas de gestación, obtenido mediante cesárea electiva por presentación pélvica, sin trabajo de parto previo. Peso al nacer: 3,450g. Apgar 8/9. A las 2 horas de vida presenta taquipnea (FR 82 rpm), quejido espiratorio leve, retracción xifoidea y cianosis peribucal que resuelve con casco cefálico a FiO2 del 40%. La radiografía de tórax muestra rectificación de arcos

costales, cisuritis, incremento del diámetro anteroposterior y discretas imágenes de "corazón peludo".

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable y su fisiopatología principal? a) Enfermedad de Membrana Hialina / Deficiencia de surfactante. b) *Taquipnea Transitoria del Recién Nacido / Retraso en la reabsorción del líquido pulmonar. c) Síndrome de Aspiración de Meconio / Obstrucción de vía aérea distal. d) Neumonía neonatal / Infección por Estreptococo del grupo B.
2. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este cuadro clínico según la normativa vigente? a) Administración de surfactante intratraqueal. b) Antibioticoterapia de amplio espectro (Ampicilina/Amikacina). c) *Asistencia ventilatoria no invasiva (CPAP) y observación, ya que suele autolimitarse en 24-72 horas. d) Intubación endotraqueal inmediata y ventilación mecánica de alta frecuencia.

Retroalimentación: La TTRN es típica de neonatos de término nacidos por cesárea sin trabajo de parto (ausencia de catecolaminas y compresión torácica que activan los canales de sodio para reabsorber líquido). Radiográficamente, la cisuritis y la hiperinsuflación son claves. El manejo es de soporte ya que es un proceso benigno.

Grado de dificultad: Bajo

Caso Clínico 6

Tema: Apendicitis Aguda.

Caso Clínico: Masculino de 24 años que inicia hace 12 horas con dolor periumbilical que posteriormente migra a fosa ilíaca derecha. Presenta náuseas, un episodio de vómito y anorexia. Signos vitales: TA 110/70 mmHg, FC 92 lpm, Temperatura 38.2°C. A la exploración: dolor a la palpación profunda en punto de McBurney, signo de Rovsing positivo y rebote (Blumberg) positivo. Laboratorios: Leucocitos 16,000/mm^3 con neutrofilia del 85%.

Preguntas e Incisos:

1. Al realizar el cálculo de la Escala de Alvarado, ¿cuántos puntos presenta el paciente y cuál es la conducta a seguir? a) 6 puntos / Observación y repetir laboratorios en 6 horas. b) 7 puntos / Realizar Tomografía Computarizada con

contraste. c) *9 puntos / Preparación quirúrgica inmediata (Apendicectomía). d) 5 puntos / Egreso con datos de alarma.

2. En caso de que este paciente fuera un adulto mayor o una mujer embarazada, ¿cuál sería el estudio de imagen de primera elección respectivamente? a) RM en ambos casos. b) TC en ambos casos. c) *TC en adulto mayor / Ultrasonido en embarazada. d) Ultrasonido en ambos casos.

Retroalimentación: El paciente cumple casi todos los criterios de Alvarado (Migración del dolor, anorexia, náusea, dolor en FID, rebote, fiebre, leucocitosis y neutrofilia), sumando 9 puntos, lo cual es diagnóstico de apendicitis según la GPC. En adultos mayores la presentación es atípica y se prefiere TC por mayor sensibilidad; en embarazadas se prefiere USG para evitar radiación ionizante. **Grado de dificultad:** Medio

---

Caso Clínico 7

Tema: Reumatología: Lupus Eritematoso Sistémico (LES).

Caso Clínico: Mujer de 28 años con cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por artralgias simétricas en manos y muñecas, astenia, adinamia y aparición de lesiones eritematosas en mejillas y dorso de la nariz que respetan el surco nasogeniano tras exposición solar. Los laboratorios reportan: Hb 10.2 g/dL, Leucocitos 3,200/mm^3, Plaquetas 140,000/mm^3, Creatinina 0.9 mg/dL. Examen General de Orina con proteinuria de 800 mg en 24 horas y presencia de cilindros granulosos.

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el anticuerpo más sensible para el tamizaje inicial y cuál es el más específico para confirmar el diagnóstico de LES? a) Anti-Ro / Anti-La. b) *ANA (Anticuerpos antinucleares) / Anti-dsDNA o Anti-Smith. c) Anti-CCP / Factor Reumatoide. d) Anticuerpos Antihistona / Anti-Scl70.

2. De acuerdo con la afectación renal (proteinuria >500mg), ¿cuál es el siguiente paso diagnóstico más importante para determinar el pronóstico y tratamiento? a) Depuración de creatinina de 24 horas. b) *Realizar biopsia renal. c) Iniciar pulsos de metilprednisolona empíricos. d) Cuantificación de niveles de complemento C3 y C4.

Retroalimentación: El LES es una enfermedad multisistémica con criterios inmunológicos y clínicos definidos. Los ANA tienen una sensibilidad >95%, mientras que el Anti-Smith es altamente específico. La presencia de proteinuria significativa obliga a realizar biopsia renal para clasificar la nefritis lúpica, ya que el tratamiento varía drásticamente entre clases (ej. clase IV vs clase II). **Grado de dificultad:** Alto

Caso Clínico 8

Tema: Hemorragias del Primer Trimestre (Aborto, Ectópico, Mola).

Caso Clínico: Paciente de 26 años, G2 C1, con amenorrea de 8 semanas. Acude por dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio y sangrado transvaginal oscuro en moderada cantidad. A la exploración: TA 110/70 mmHg, FC 85 lpm. Al tacto vaginal, el cérvix se encuentra formado, con orificio cervical interno abierto; se palpan restos ovulares en el canal vaginal. El útero tiene un tamaño menor al esperado por fecha de última regla.

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el diagnóstico clínico correcto? a) Aborto diferido. b) Aborto inevitable. c) *Aborto incompleto. d) Aborto en evolución.
2. Según la GPC, ¿cuál es el tratamiento de elección si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable y el tamaño uterino es <11 cm con dilatación cervical? a) *Aspiración Manual Endouterina (AMEU). b) Legrado Uterino Instrumental (LUI). c) Manejo expectante por 2 semanas. d) Administración de Metotrexato dosis única.

Retroalimentación: El diagnóstico es aborto incompleto debido a la apertura del OCI y la expulsión parcial de productos. La GPC establece que la AMEU es preferible sobre el LUI en úteros menores a 11 cm y con dilatación de 1 cm, ya que presenta menores tasas de complicaciones (perforación, sinequias) y menor tiempo de estancia hospitalaria. **Grado de dificultad:** Medio

---

Caso Clínico 9

Tema: Patología Neonatal Metabólica (Hijo de madre diabética, Electrolitos).

Caso Clínico: Recién nacido de 38 semanas, hijo de madre con DM2 mal controlada. Peso al nacer 4,350 g (Macrosómico). A las 2 horas de vida, el neonato presenta temblores finos, irritabilidad, succión débil y letargia. Se toma glucemia capilar reportando 35 mg/dL. Se inicia alimentación vía oral inmediata, sin embargo, a los 30

minutos la glucemia central es de 30 mg/dL y el paciente presenta una crisis convulsiva tónica generalizada.

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el manejo inmediato de elección para este paciente? a) Nueva carga de fórmula láctea por sonda orogástrica. b) *Bolo de Solución Glucosada al 10% (2 ml/kg) seguido de infusión continua (VIG 6-8 mg/kg/min). c) Administración de Glucagón intramuscular. d) Bolo de Gluconato de Calcio al 10%.
2. ¿Cuál es la malformación congénita cardiaca más frecuente en hijos de madre diabética y cuál es la más específica? a) *Comunicación Interventricular (Frecuente) / Transposición de Grandes Vasos (Específica). b) Comunicación Interatrial / Tetralogía de Fallot. c) Persistencia del Conducto Arterioso / Coartación de Aorta. d) Miocardiopatía Hipertrófica / Atresia Tricuspídea.

Retroalimentación: La hipoglucemia sintomática o grave (convulsiones) en el neonato requiere manejo parenteral inmediato con bolo de dextrosa al 10%. En hijos de madre diabética, aunque la CIV es la malformación más común, la Transposición de Grandes Vasos y el Síndrome de Colon Izquierdo Hipoplásico son los hallazgos más específicos asociados a la embriopatía diabética.

Grado de dificultad: Alto

Caso Clínico 10

Tema: Diabetes Mellitus: Fisiopatología y Diagnóstico.

Caso Clínico: Masculino de 45 años, sin antecedentes de importancia, acude a revisión rutinaria de empresa. Se encuentra asintomático. Exploración física: IMC 31 kg/m^2, acantosis nigricans en cuello. Resultados de laboratorio: Glucosa en ayuno de 118 mg/dL. Se repite la prueba a la semana, obteniendo 122 mg/dL. Se solicita Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) la cual reporta 6.3%.

Preguntas e Incisos:

1. De acuerdo con los criterios de la NOM-015-SSA2 y la ADA, ¿cuál es el estado diagnóstico del paciente? a) Sano. b) *Prediabetes (Glucosa anormal en ayuno). c) Diabetes Mellitus tipo 2. d) Intolerancia a la glucosa.

2. ¿Cuál es el siguiente estudio para confirmar o descartar definitivamente el diagnóstico de Diabetes en este paciente? a) Repetir la HbA1c en 3 meses. b) *Curva de tolerancia a la glucosa oral (CTGO) con 75g de carga. c) Glucosa aleatoria en sangre. d) Cuantificación de péptido C.

Retroalimentación: El paciente tiene criterios de prediabetes (Ayuno 100-125 mg/dL y HbA1c 5.7-6.4%). Ante la discrepancia o valores limítrofes, la CTGO es la prueba diagnóstica con mayor sensibilidad para detectar DM2 en etapas tempranas. Se debe iniciar intervención en estilo de vida y considerar metformina según factores de riesgo adicionales. **Grado de dificultad:** Medio

+1

Caso Clínico 11

Tema: Patología de Vesícula y Vías Biliares.

Caso Clínico: Femenina de 42 años, con antecedentes de múltiples cuadros de dolor en hipocondrio derecho tras ingesta de colecistoquinéticos. Acude a urgencias por dolor persistente de 12 horas en la misma localización, irradiado a escápula derecha, acompañado de fiebre de 38.5°C y náuseas. A la exploración: signo de Murphy positivo. Laboratorios: Leucocitos 14,000/mm^3, Bilirrubina total 1.1 mg/dL. El ultrasonido reporta pared vesicular de 5 mm, lito impactado en el cuello y líquido perivesicular.

Preguntas e Incisos:

1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el grado de severidad según las Guías de Tokio vigentes? a) Colelitiasis sintomática / Grado I. b) *Colecystitis aguda / Grado I (Leve). c) Colecystitis aguda / Grado II (Moderada). d) Coledocolitiasis / Grado III (Grave).
2. ¿Cuál es el manejo definitivo recomendado para este caso? a) Colecistectomía programada en 6 semanas. b) *Colecistectomía laparoscópica temprana (dentro de las primeras 72 horas). c) CPRE seguida de colecistectomía. d) Antibioticoterapia y drenaje percutáneo por punción.

Retroalimentación: La paciente presenta colecistitis aguda (Murphy +, fiebre, leucocitosis y hallazgos por USG como pared >4mm). Al no tener falla orgánica ni criterios de inflamación local severa (como absceso o peritonitis), se clasifica como

Grado I. El tratamiento de elección es la colecistectomía laparoscópica temprana para disminuir la estancia hospitalaria y complicaciones. **Grado de dificultad:** Medio